

### A) classification:

| Classe chimique                       | DCI                                                                                                                          | Spécialité                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phénothiazines</b>                 | - Alimémazine<br>- Chlorpromazine<br>- Fluphénazine dichlorhydrate<br>- Lévomépromazine<br>- Pipotiazine<br>- Propériciazine | - Théralène®<br>- Largactil®<br>- Moditen®<br>- Nozinan®<br>- Piportil®<br>- Neuleptil® |
| <b>Butyrophénones</b>                 | - Halopéridol                                                                                                                | - Haldol®                                                                               |
| <b>Benzamides</b>                     | - Amisulpride<br>- Sulpiride                                                                                                 | - Solian®<br>- Dogmatil®                                                                |
| <b>Thioxanthènes</b>                  | - Flupentixol                                                                                                                | - Fluanxol®                                                                             |
| <b>Autres structures tricycliques</b> | - Clozapine<br>- Olanzapine<br>- Quétiapine                                                                                  | - Léponex®<br>- Zyprexa®                                                                |
| <b>Structures bicycliques</b>         | - Risperidone<br>- Ziprasidone                                                                                               | - Risperdal®<br>- Zeldox®                                                               |

### B) Indications des neuroleptiques:

- États psychotiques aigus et chroniques.
- Mouvements anormaux (maladie de Huntington, syndrome de Gilles de la tourette).
- Certains cas (TOC, troubles psychosomatiques).
- États d'agitations, d'agressivité et d'impulsivité, d'angoisse extrême.
- Algies intenses (cancer, névralgie du trijumeau, zona).
- Troubles endocriniens (bouffées de chaleur).
- Vomissements d'origine centrale et périphérique.
- En anesthésie (prémédication).

### \* Contre-indications des neuroleptiques:

#### - Absolues:

- 1) Phéochromocytome (Benzamides surtout).
- 2) Défaillance poly-viscérale, Comas.

- **à l'arrêt**: effet rebond.

- **si arrêt brutal**: syndrome de sevrage (tremblements, crampes, nausées...).

- après un traitement long (= + de 4 semaines) ou à fortes doses, l'arrêt doit se faire sur plusieurs semaines, en diminuant les doses progressivement.

- La prescription est maintenant réglementée et limitée à 4 ou 12 semaines, selon les produits et il est recommandé d'administrer la dose minimale efficace.

### **\* Risque en cas de surdosage:**

- Contrairement aux barbituriques, le surdosage de BZD seules ne met pas en danger la vie du patient: il justifie néanmoins une hospitalisation en réanimation.

### **\* Terrains fragiles vis-à-vis des benzodiazépines:**

- **les personnes âgées**: car les effets secondaires sont plus lourds de conséquences: l'amnésie, les pertes cognitives, risque d'induction d'un syndrome confusionnel, l'effet myorelaxant peut entraîner des pertes d'équilibre et perturbe la déglutition (risque de \*fausses routes\*).

- **l'insuffisant respiratoire**, à cause de l'effet myorelaxant.

- **l'insuffisant hépatique et rénal**, il faut adapter la posologie.

- **la grossesse et l'allaitement**: aucun effet tératogène n'a été mis en évidence mais il faut éviter ces traitements le 1<sup>er</sup> et le dernier trimestre.

### **\* les problèmes posés par les anxiolytiques et les hypnotiques:**

- Médicaments très souvent détournés (mésusage) dans un but toxicomane.

- Fréquence des ordonnances falsifiées: pharmacien doit être vigilant et doit relever les irrégularités et les prescriptions illogiques.

- Agressions dans les officines le plus souvent en rapport avec vol d'anxiolytiques et d'hypnotiques.



- relâchement, relaxation musculaire, décontraction en particulier \*le Valium\*.

#### \* action anticonvulsivante:

- certains sont utilisés comme antiépileptiques: Klonopin \*et le Valium\*.

#### B) Les anxiolytiques autres que les benzodiazépines:

- Hydroxyzine = \*ATARAX\*

Il n'entraîne pas de dépendance mais son activité est inconstante.

#### C) Les hypnotiques autres que benzodiazépiniques :

##### - IMOVANE:

- mécanisme d'action très voisin des BZD, mais il respecterait mieux l'architecture du sommeil.
- mêmes effets indésirables, même dépendance.
- son élimination est en partie salivaire, ce qui explique qu'il laisse un goût amer dans la bouche au réveil.

##### - STILNOX:

- action sur le GABA.
- respect du sommeil paradoxal.
- mêmes effets secondaires que les BZD.

- MEPRONIZINE: = association d'un Neuroleptique (phenothiazine) et d'un carbamate.

#### \* Effets secondaires:

- Ils sont en rapport avec la posologie, la durée du traitement et la sensibilité individuelle du patient.
- Les troubles de la vigilance = la somnolence: effet résiduel des hypnotiques le matin, effet secondaire gênant des anxiolytiques ; attention aux conducteurs de voitures ou de machines; ces troubles sont accentués par la prise concomitante d'alcool.
- Les troubles cognitifs = amnésie antérograde, observés surtout avec la voie injectable et chez les personnes âgées.

### **1) Maladies neurologiques:**

- Antécédent d'arriération ou d'encéphalite (risque de syndrome malin accru).
- Myasthénie.
- Epilepsie.
- Maladies neurologiques évolutives (SEP, Parkinson).

### **2) Porphyrisme.**

### **3) Glaucome à angle fermé et troubles uréthro- prostatiques.**

### **4) Troubles Hématologiques: Neutropénies, antécédent d'agranulocytose toxique, Hémopathie toxique : Proscrire Clozapine+++.**

### **5) Insuffisance Rénale, Hépatique, Cardiaque.**

### **6) Sujet âgé: Eviter molécules trop sédatives, incisives ou trop anticholinergiques.**

### **7) Grossesse: Eviter 1er T même si risque tératogène est faible; Renoncer à allaitement; Haldol et Largactil autorisés.**

## **III- Les Antidépresseurs:**

- Psychotropes appartenant au groupe des psychoanaleptiques (Delay et Deniker 1953).
- Améliorent l'humeur déprimée en agissant sur l'ensemble du syndrome dépressif.

### **\* Contre- indications:**

#### **1- Absolues:**

- Glaucome aigu à angle fermé.
- Hypertrophie bénigne de la prostate.
- Cardiopathie non stabilisées.
- IDM.
- Insuffisance cardiaque décompensée.
- 1<sup>er</sup> trimestre de grossesse.
- Association avec IMAO non sélectifs.

- Épilepsie.
- Insuffisance hépatique et rénale.

#### **IV- Les Thymorégulateurs:**

- L'action normothymique ou thymorégulatrice est une action régulatrice de l'humeur.
- Les indications sont majoritairement les troubles bipolaires.